



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/770/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS CEK KESEHATAN GRATIS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan diperlukan langkah strategis, salah satunya dengan Program Hasil Terbaik Cepat termasuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau disebut juga dengan Cek Kesehatan Gratis;
- b. bahwa salah satu program Cek Kesehatan Gratis adalah Cek Kesehatan Gratis Sekolah yang dilaksanakan untuk mencegah dan menangani faktor risiko, kondisi pra-penyakit, dan penyakit secara dini pada anak usia 7-17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS CEK KESEHATAN GRATIS SEKOLAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis Sekolah yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis CKG Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis CKG Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pimpinan Puskesmas, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya, satuan pendidikan, dan pihak lainnya dalam:

- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis Sekolah (CKG Sekolah);
- b. menyusun dan menyelenggarakan strategi komunikasi CKG Sekolah; dan
- c. melakukan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi CKG Sekolah.

KETIGA : Sasaran CKG Sekolah meliputi:

- a. peserta didik yang berada di satuan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 12 atau sederajat termasuk pesantren;
- b. anak usia 7-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan; dan
- c. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

- KEEMPAT : CKG Sekolah bagi kelompok sasaran peserta didik yang berada di satuan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 12 atau sederajat termasuk pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dilaksanakan di satuan pendidikan termasuk pesantren oleh petugas Puskesmas bersama tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- KELIMA : CKG Sekolah bagi kelompok sasaran anak usia 7-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, dan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dilaksanakan di Puskesmas atau FKTP lain.
- KEENAM : CKG Sekolah bagi kelompok sasaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan mengikuti standar Pemeriksaan Kesehatan Gratis hari ulang tahun.
- KETUJUH : Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/770/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS CEK KESEHATAN
GRATIS SEKOLAH

PETUNJUK TEKNIS
CEK KESEHATAN GRATIS SEKOLAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Delapan Misi Asta Cita Kepemimpinan Presiden terpilih tahun 2024-2029, yang mencakup berbagai aspek pembangunan nasional memuat misi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM ini ditujukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing di tingkat global. Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di seluruh kabupaten di Indonesia, penurunan kasus tuberkulosis sebanyak 50% dalam 5 tahun, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

CKG dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini difokuskan pada upaya promotif dan preventif yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berbasis kelompok sasaran (*people-centered*). CKG ditujukan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Pelayanan ini didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik sektor pemerintah maupun swasta.

CKG Sekolah merupakan bagian dari CKG seluruh siklus hidup yang dilakukan dan ditujukan kepada peserta didik yang berada di satuan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 12 atau sederajat termasuk pesantren, anak usia 7-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan, dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di satuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

kesehatan, sehingga mendorong pencegahan penyakit yang lebih efektif dan penanganan yang lebih terarah.

Hasil Survei Kesehatan Indonesia dan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2023 mengungkapkan berbagai tantangan kesehatan di setiap tahapan siklus hidup. Pada anak usia sekolah dan remaja terdapat 7,4% usia 10-18 tahun yang merokok, serta 16,3% usia 5-14 tahun dan 15,5% usia 15-24 tahun mengalami anemia. Berdasarkan *Global School Health Survey* tahun 2024 pada usia 13–17 tahun, didapatkan 5,1% anak mengonsumsi alkohol, 17,6% *overweight*, 5,4% obesitas, 76,2% tidak aktif secara fisik, 17,8% merokok, 12,6% merokok elektrik, dan 10,7% anak sekolah yang mencoba melakukan bunuh diri.

CKG Sekolah merupakan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilaksanakan oleh sektor kesehatan berkolaborasi dengan sektor pendidikan, agama, dan sosial dalam kerangka upaya Kesehatan Sekolah. Pelaksanaan CKG Sekolah yang komprehensif akan berkontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

CKG Sekolah merupakan inovasi baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan peserta didik secara berkala dan memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan. Agar persiapan dan pelaksanaan CKG Sekolah terselenggara dengan baik, maka diperlukan Petunjuk Teknis sebagai panduan untuk memastikan keterpaduan, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan CKG Sekolah di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran Petunjuk Teknis

1. Tujuan Umum

Menyediakan panduan pelaksanaan CKG Sekolah.

2. Tujuan Khusus

Menyediakan panduan mengenai:

- a. paket pelayanan CKG Sekolah;
- b. tahapan penyelenggaraan CKG Sekolah;
- c. pendanaan CKG Sekolah;
- d. pencatatan dan pelaporan CKG Sekolah;
- e. strategi komunikasi, informasi, dan edukasi CKG Sekolah; dan
- f. monitoring dan evaluasi CKG Sekolah.

3. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini antara lain:

- a. kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala desa/lurah;
- b. dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
- c. dinas pendidikan daerah provinsi dan dinas pendidikan daerah kabupaten/kota;
- d. kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota;
- e. dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota;
- f. kepala puskesmas, penanggung jawab klaster, dan pimpinan FKTP lainnya;
- g. penyelenggara pendidikan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- h. kepala sekolah/madrasah/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat serta tim pelaksana UKS/M di satuan pendidikan;
- i. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE); dan
- j. organisasi profesi, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, sektor swasta dan pihak lainnya.

BAB II

PAKET PELAYANAN CEK KESEHATAN GRATIS SEKOLAH

CKG Sekolah adalah upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya peserta didik tentang pentingnya kesehatan. Program ini memanfaatkan momentum tahun ajaran baru sebagai waktu pelaksanaan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan peserta didik yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius. Program ini mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui pemberian layanan kesehatan gratis kepada peserta didik dan pemberian edukasi untuk memahami hasil pemeriksaan serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. CKG Sekolah diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses belajar.

Pelaksanaan program ini didukung dengan pemanfaatan Platform SATUSEHAT selaku Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan meliputi SATUSEHAT Mobile (SSM) dan SATUSEHAT IndonesiaKu (SSI) sebagai sarana pencatatan/pemantauan pelayanan kesehatan di luar gedung bagi tenaga kesehatan di layanan primer, serta sistem elektronik yang dikelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat lain yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Paket pelayanan dalam CKG Sekolah meliputi beberapa jenis pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan jenjang Pendidikan atau kelompok umur pada sasaran dalam CKG Sekolah.

A. Tujuan dan Sasaran CKG Sekolah

Tujuan CKG sekolah:

1. Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan agar peserta didik tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit;
2. Mendeteksi kondisi pra penyakit agar tidak berkembang menjadi penyakit; dan
3. Mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat diberikan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi serta menurunkan risiko kecacatan dan kematian.

Sasaran CKG Sekolah:

1. Peserta didik yang berada di satuan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 12 atau sederajat termasuk pesantren, meliputi:
 - a. Peserta didik usia 7–17 tahun yang berada di satuan pendidikan

dari kelas 1 hingga kelas 12 atau sederajat termasuk pesantren;
dan

- b. Peserta didik usia <7 tahun dan >17 tahun yang berada di satuan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 12 atau sederajat termasuk pesantren;
2. Anak usia 7-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan; dan
3. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan:

1. CKG Sekolah dilaksanakan mulai tahun ajaran baru bulan Juli tahun berjalan.
2. CKG bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan mengikuti mekanisme program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun di FKTP secara mandiri atau terkoordinasi sesuai kesepakatan pengaturan antara Sekolah dengan FKTP.

Tempat pelaksanaan:

1. CKG Sekolah bagi kelompok sasaran peserta didik yang berada di satuan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 12 atau sederajat termasuk pesantren dilaksanakan di sekolah/madrasah/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat oleh petugas Puskesmas.
2. CKG Sekolah bagi kelompok sasaran anak usia 7-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan, dan bagi kelompok sasaran tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dilaksanakan di Puskesmas atau FKTP lain.

C. Jenis Pemeriksaan

1. Jenis pemeriksaan pada peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak berusia 7-12 tahun yang berada di luar satuan pendidikan meliputi:
 - a. Status Gizi;
 - b. Riwayat Imunisasi (kelas 1);
 - c. Merokok (kelas 4, 5, dan 6);
 - d. Kebugaran (kelas 4, 5, dan 6);
 - e. Telinga;
 - f. Mata;

- g. Gigi;
 - h. Kesehatan Jiwa;
 - i. Tekanan Darah;
 - j. Gula Darah;
 - k. Tuberkulosis;
 - l. Hati: Hepatitis B; dan
 - m. Kesehatan Reproduksi (kelas 4, 5, dan 6).
2. Jenis pemeriksaan pada peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak berusia 13-15 tahun yang berada di luar satuan pendidikan meliputi:
- a. Status Gizi;
 - b. Merokok;
 - c. Kebugaran;
 - d. Telinga;
 - e. Mata;
 - f. Gigi;
 - g. Kesehatan Jiwa;
 - h. Tekanan Darah;
 - i. Gula Darah;
 - j. Anemia (kelas 7 putra dan putri);
 - k. Talasemia;
 - l. Tuberkulosis;
 - m. Hati: Hepatitis B dan C;
 - n. Kesehatan Reproduksi; dan
 - o. Riwayat imunisasi HPV (kelas 9 putri).
3. Jenis pemeriksaan pada peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak berusia 16-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan meliputi:
- a. Status Gizi;
 - b. Merokok;
 - c. Kebugaran;
 - d. Telinga;
 - e. Mata;
 - f. Gigi;

- g. Kesehatan Jiwa;
- h. Tekanan Darah;
- i. Gula Darah;
- j. Anemia (kelas 10 putri);
- k. Talasemia;
- l. Tuberkulosis;
- m. Hati: Hepatitis B dan C; dan
- n. Kesehatan Reproduksi.

D. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan berikut ini dilakukan dengan metode yang sama untuk semua jenjang pendidikan dan kelompok usia sasaran:

1. Status gizi: pengukuran antropometri tinggi badan, berat badan, dan penghitungan indeks massa tubuh.
2. Merokok: pengisian kuesioner mandiri.
3. Telinga: pemeriksaan fungsi pendengaran dengan tes berbisik dan pemeriksaan serumen prop melalui pemeriksaan liang telinga dengan menggunakan otoskop.
4. Mata: pemeriksaan mata luar serta tes tajam penglihatan menggunakan *snellen chart* atau *e-tumbling*. Apabila terdapat keterbatasan ruangan dapat dilakukan skrining menggunakan kartu tajam penglihatan satu baris pada jarak 3m dengan batasan ukuran 6/9. Apabila ditemukan hasil visus <6/9 dilakukan pemeriksaan lanjutan trial lens di Puskesmas. Kartu tajam penglihatan satu baris dapat dicetak mandiri dengan mengikuti ketentuan dan panduan yang tersedia. Untuk file kartu dan video langkah pemeriksaan dapat diakses melalui link berikut: s.kemkes.go.id/TesTajamPenglihatan3m.
5. Gigi: pemeriksaan karies gigi.
6. Kesehatan jiwa: pengisian kuesioner mandiri.
7. Tekanan darah: pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter.
8. Anemia: pemeriksaan kadar hemoglobin darah menggunakan Hb meter.
9. Tuberkulosis: pengisian kuesioner mandiri, sesuai faktor risiko dilanjutkan dengan pemeriksaan sputum di Puskesmas.
10. Riwayat imunisasi: pengisian kuesioner mandiri.
11. Kesehatan reproduksi: pengisian kuesioner mandiri.

Pengisian kuesioner pada anak SD/MI/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 7-12 tahun yang berada di luar satuan pendidikan dapat dibantu oleh orang tua/wali atau guru.

Pemeriksaan berikut ini dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenjang pendidikan:

1. Kebugaran

- a. Untuk anak kelas 4-6 SD/MI/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 7-12 tahun yang berada di luar satuan Pendidikan dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner *Par-Q Child*, dilanjutkan *Single test* 1000 m atau *Bleep test* untuk kelas 4-6 (usia untuk kelas > 10 tahun) jika tidak ada risiko berdasarkan kuesioner *Par-Q Child*.
- b. Untuk semua anak SMP/MTs/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 13-15 tahun yang berada di luar satuan pendidikan dan semua anak SMA/MA/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 16-17 tahun yang berada di luar satuan Pendidikan dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner *Par-Q Child*, dilanjutkan *Single test* 1600 m atau *Bleep test* jika tidak ada risiko berdasarkan hasil kuesioner *Par-Q Child*.

2. Gula Darah

- a. Untuk semua anak SD/MI/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 7 – 12 tahun yang berada di luar satuan Pendidikan dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner mandiri, sesuai faktor risiko dilanjutkan pemeriksaan gula darah sewaktu di Puskesmas.
- b. Untuk anak SMP/MTs/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 13-15 tahun yang berada di luar satuan pendidikan:
 - 1) Kelas 7 atau usia 13 tahun dilaksanakan dengan metode pemeriksaan gula darah sewaktu.
 - 2) Kelas 8-9 atau usia 14-15 tahun dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner mandiri, sesuai faktor risiko dilanjutkan pemeriksaan gula darah sewaktu di Puskesmas.
- c. Untuk semua anak SMA/MA/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 16-17 tahun

yang berada di luar satuan Pendidikan dilaksanakan dengan metode pemeriksaan gula darah sewaktu.

3. Talasemia

- a. Untuk peserta didik SMP/MTs/pesantren, atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau pada anak usia 13-15 tahun yang berada di luar satuan pendidikan:
 - 1) Kelas 7 atau usia 13 tahun dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan suspek talasemia (darah lengkap) di Puskesmas yang memiliki faktor risiko talasemia atau Hb di bawah 12 mg/dL.
 - 2) Kelas 8-9 atau usia 14-15 tahun dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan suspek talasemia (darah lengkap) di Puskesmas bagi yang memiliki faktor risiko talasemia.
- b. Untuk peserta didik SMA/MA/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau usia 16-17 tahun dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan suspek talasemia (darah lengkap) di Puskesmas bagi yang memiliki faktor risiko talasemia.

4. Hepatitis B dan Hepatitis C

- a. Untuk semua anak SD/MI/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau usia 7-12 tahun dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan RDT Hepatitis B di Puskesmas bagi anak yang memiliki faktor risiko.
- b. Untuk semua anak SMP/MTs/pesantren sederajat dan semua anak SMA/MA/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau usia 13-17 tahun dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan pemeriksaan RDT Hepatitis B dan Hepatitis C bagi anak yang memiliki faktor risiko.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CEK KESEHATAN GRATIS SEKOLAH

A. Persiapan

1. Tenaga Pelaksana:

- a. guru penanggung jawab UKS atau lainnya untuk membantu pengukuran berat badan dan tinggi badan;
- b. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) atau guru lain untuk membantu dalam pengukuran lapangan lokasi pemeriksaan dan melakukan tes kebugaran jasmani sesuai standar jarak tempuh; dan
- c. Petugas Puskesmas: minimal dua tenaga medis dan atau tenaga kesehatan (dokter/perawat/bidan).

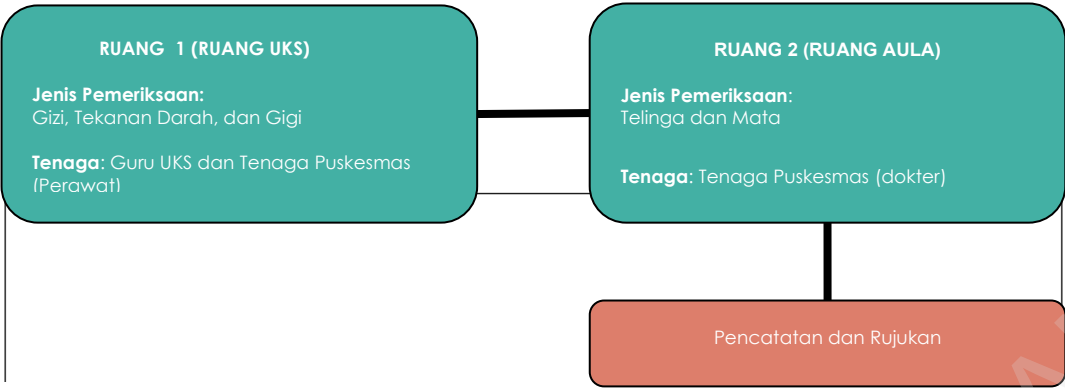
2. Sarana dan Prasarana

- a. Pemeriksaan membutuhkan dua ruangan, masing-masing untuk:
 - 1) pemeriksaan status gizi, tekanan darah, anemia, hepatitis dan gula darah; dan
 - 2) pemeriksaan gigi, mata dan telinga. Ruangan untuk pemeriksaan telinga (termasuk fungsi pendengaran) ini sebaiknya cukup luas dan tidak bising.

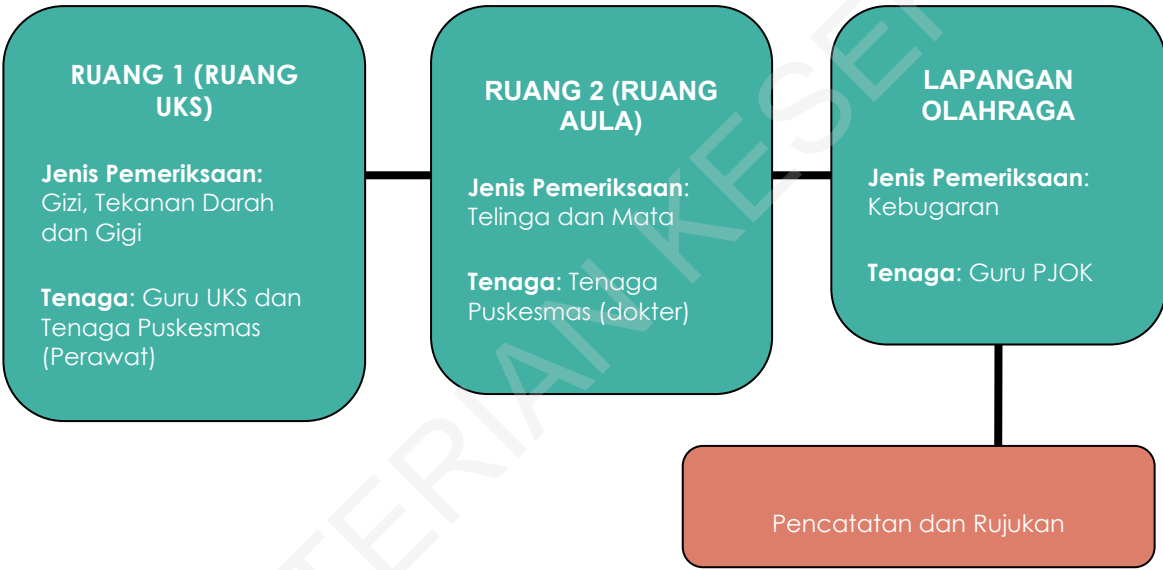
Contoh pembagian ruangan pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3

- b. Lapangan olahraga untuk melakukan tes kebugaran
- c. Sistem pencatatan SATUSEHAT IndonesiaKu
- d. Alat pemeriksaan kesehatan sebagaimana Tabel 1.

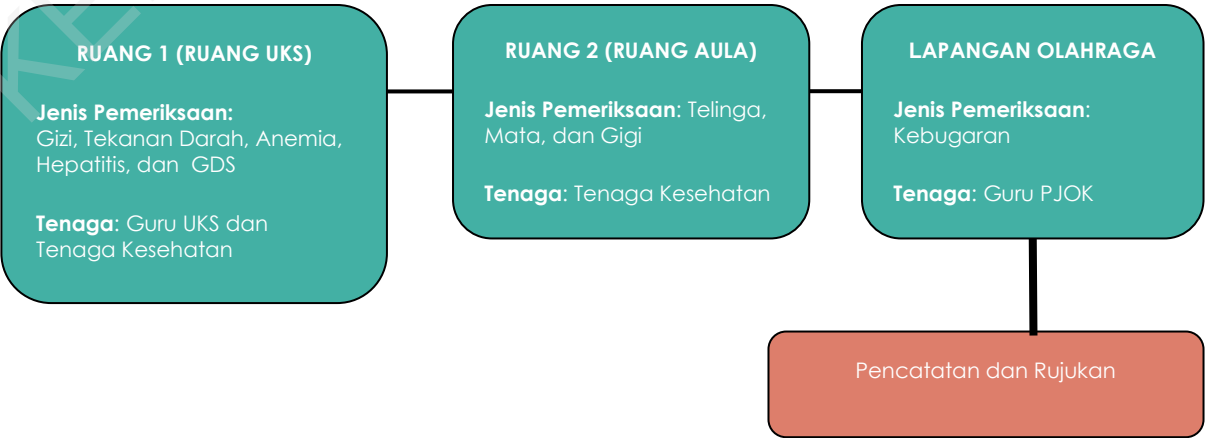
Gambar 1. Contoh Pembagian Ruang Pemeriksaan untuk kelas 1-3 SD/MI/Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat



Gambar 2. Contoh Pembagian Ruang Pemeriksaan untuk Kelas 4-6 SD/MI/Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat



Gambar 3. Contoh Pembagian Ruang Pemeriksaan untuk Kelas 7-9 SMP/MTs/Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat, Kelas 10-12 SMA/SMK/MA/Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat



Tabel 1. Alat Pemeriksaan Kesehatan CKG Sekolah

No	Pemeriksaan	Alat yang dibutuhkan	BMHP yang dibutuhkan	Disediakan oleh
1	Status Gizi	Timbangan digital Stadiometer	-	Satuan Pendidikan
2	Mata	Snellen chart/ e-tumbling/kartu tajam penglihatan satu baris	-	
3	Kebugaran	Stopwatch	-	
4	Telinga	otoskop	-	Puskesmas
5	Tekanan Darah	Tensimeter digital dan manset anak	-	
6	Diabetes Melitus	Glukometer	Lancet Alkohol swab Strip Gula Darah	
7	Anemia	Hb meter	Lancet Alkohol swab Strip Hb	
8	Gigi	Penlight		
9	Hepatitis B	-	Lancet Alkohol swab RDT HbsAg (Hepatitis B)	
10	Hepatitis C		RDT Anti HCV (Hepatitis C)	

B. Pembagian Peran

1. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi

- a. Koordinasi, orientasi dan sosialisasi kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- b. Koordinasi dengan dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan dinas sosial.
- c. Melakukan identifikasi kesenjangan kebutuhan dan menyusun strategi pemenuhan yang dapat dilakukan oleh dinas kesehatan daerah provinsi.

2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Melakukan pemetaan satuan pendidikan dan jumlah peserta didik di wilayah kabupaten/kota.
- b. Menetapkan distribusi sasaran CKG Sekolah per Puskesmas.
- c. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial dalam persiapan implementasi CKG Sekolah.
- d. Melakukan identifikasi kesenjangan kebutuhan dan menyusun strategi pemenuhan.
- e. Memetakan kesiapan Puskesmas pelaksana CKG Sekolah:
 - 1) memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas; dan
 - 2) dinas kesehatan dapat mengajukan kebutuhan BMHP kepada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Pengajuan BMHP ke Kementerian Kesehatan memperhitungkan alokasi BMHP yang dianggarkan melalui APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan BMHP CKG Sekolah dihitung berdasarkan sasaran pemeriksaan sebagai berikut:

- a. diabetes melitus (gula darah): peserta didik kelas 7, 10, 11 dan 12 di satuan pendidikan;
- b. skrining anemia: peserta didik kelas 7 remaja putra dan remaja putri serta kelas 10 remaja putri di satuan pendidikan;
- c. Hepatitis B: prevalensi Hepatitis B x jumlah sasaran peserta didik (kelas 1-12) X 2; dan
- d. Hepatitis C: prevalensi Hepatitis C x jumlah sasaran peserta didik (kelas 7-12) X 2.

Perhitungan BMHP berdasarkan jumlah sasaran peserta didik dari tingkat SD/MI/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat hingga SMA/MA/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan.

Estimasi kebutuhan BMHP = jumlah sasaran + 10% kemungkinan penambahan sasaran

Secara umum, perhitungan BMHP harus memperhitungkan stok yang ada, sehingga penghitungan menjadi:

Kebutuhan Akhir = Kebutuhan + Buffer - Sisa Stok

Puskesmas di wilayah kab/kota harus selalu memiliki ketersediaan stok BMHP untuk 3 (tiga) bulan ke depan.

3. Puskesmas

- a. Menghitung sasaran satuan pendidikan dan peserta didik penerima CKG Sekolah sesuai jenjang pendidikan.
- b. Sasaran Puskesmas dapat didelegasikan kepada Puskesmas Pembantu (Pustu) atau Unit Pelayanan Kesehatan tingkat Desa/Kelurahan (UPKDK) lainnya yang ada di wilayahnya, dengan mempertimbangkan:
 - 1) kesiapan Puskesmas Pembantu atau Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan (UPKDK) lainnya berdasarkan sumber daya manusia, alat kesehatan dan BMHP.
 - 2) Puskesmas dapat memberikan BMHP (berupa *rapid test* atau *strip test* dan BMHP lainnya) kepada Pustu atau UPKDK lainnya.
- c. Mendaftarkan sekolah di wilayah kerja Puskesmas
Setiap Puskesmas perlu mendaftarkan seluruh sekolah yang berada di wilayah kerjanya melalui Website SATUSEHAT IndonesiaKu.
- d. Memetakan ketersediaan alat kesehatan, BMHP dan rencana pemenuhannya.
- e. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan di wilayah kerja dan menetapkan jadwal kegiatan CKG Sekolah.

- f. Membuat rancangan alur pelayanan.
 - g. Mengidentifikasi tenaga Puskesmas yang akan memberikan pelayanan CKG Sekolah.
 - h. Menyiapkan informasi singkat tentang CKG Sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali.
 - i. Menunjuk dan mendaftarkan administrator SATUSEHAT Indonesiaku (SSI) Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan.
 - j. Memastikan administrator SATUSEHAT di Puskesmas mendaftarkan tenaga Puskesmas yang akan menginput data layanan CKG di website SATUSEHAT IndonesiaKu.
4. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- a. Menyediakan data satuan pendidikan dan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, pesantren, atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
 - b. Menyampaikan surat edaran pelaksanaan CKG Sekolah ke satuan pendidikan di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, pesantren, atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
 - c. Melakukan sosialisasi dan orientasi pelaksanaan CKG Sekolah kepada Kepala Sekolah dan guru.
 - d. Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan CKG Sekolah.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CKG Sekolah bersama Dinas Kesehatan.
 - f. Melakukan tindak lanjut pelaksanaan CKG Sekolah baik edukasi, konseling dan rujukan ke Puskesmas.
5. Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota
- a. Menyediakan data satuan pendidikan dan peserta didik di jenjang MI, MTs, MA, pesantren dan satuan pendidikan berbasis keagamaan lainnya.
 - b. Menyampaikan surat edaran pelaksanaan CKG Sekolah ke satuan pendidikan di jenjang MI, MTs, MA dan pesantren dan satuan pendidikan berbasis keagamaan lainnya.
 - c. Melakukan sosialisasi dan orientasi pelaksanaan CKG Sekolah kepada kepala madrasah, kepala pesantren, kepala satuan pendidikan berbasis keagamaan lainnya, tim pelaksana UKS/M dan pos kesehatan pesantren.

- d. Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan CKG Sekolah.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CKG Sekolah bersama Dinas Kesehatan.
 - f. Mendorong tindak lanjut pelaksanaan CKG Sekolah baik edukasi, konseling dan rujukan ke Puskesmas.
6. Dinas Sosial Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- a. Menyediakan data Sekolah Rakyat (SR) dan peserta didik SR.
 - b. Menyampaikan surat edaran pelaksanaan CKG Sekolah ke Sekolah Rakyat.
 - c. Melakukan sosialisasi dan orientasi pelaksanaan CKG Sekolah kepada Kepala Sekolah dan Tim pelaksana UKS.
 - d. Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan CKG Sekolah.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CKG Sekolah bersama Dinas Kesehatan.
 - f. Melakukan tindak lanjut pelaksanaan CKG Sekolah baik edukasi, konseling dan rujukan ke Puskesmas.
7. Sekolah/Madrasah/Pesantren Atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat
- a. Mendata peserta didik tiap jenjang pendidikan dan jenis kelamin serta menyampaikan kepada Puskesmas.
 - b. Menginformasikan kepada peserta didik atau orang tua/wali tentang pelaksanaan CKG Sekolah: tata cara pendaftaran dan pengisian kuesioner skrining mandiri kesehatan anak. Penyampaian informasi bisa dilakukan pada jam literasi sekolah, kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), rapat dan pertemuan orang tua/wali dan komite sekolah pada awal tahun ajaran baru, grup WhatsApp guru dan orang tua/wali, mading sekolah, media sosial sekolah, dan kegiatan kesiswaan yang melibatkan peserta didik dll.
 - c. Memastikan peserta didik atau orang tua/wali telah melakukan pendaftaran CKG Sekolah dan mengisi kuesioner skrining mandiri sebelum pelaksanaan CKG Sekolah.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana CKG dan tenaga Guru dalam membantu pelaksanaan CKG Sekolah.

- e. Melakukan koordinasi tentang kesiapan peserta didik, guru, sarana prasarana dan jadwal CKG Sekolah dengan Puskesmas.

8. Kelompok Sasaran

Peserta didik atau anak usia 7–17 tahun di luar satuan pendidikan dan dapat dibantu orang tua/wali mengunduh untuk memiliki akun di aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM) untuk mengakses CKG Sekolah. Peserta didik dan anak usia 7–17 di luar satuan pendidikan melakukan pendaftaran melalui SATUSEHAT Mobile atau WhatsApp Chatbot Kemenkes RI. Langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan CKG Sekolah sebagai berikut:

a. Pendaftaran melalui SATUSEHAT Mobile (SSM)

- 1) Peserta didik dan anak usia 7–17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan mengunduh aplikasi SSM melalui Google Play Store bagi pengguna telepon genggam Android, dan melalui App Store bagi pengguna iOS.
- 2) Untuk kemudahan akses, orang tua/wali dapat melakukan login/masuk ke SSM menggunakan akun pribadi orang tua/wali, dan menggunakan fitur ‘profil tertaut’ untuk menambahkan data anak. Orang tua/wali dapat menautkan lebih dari satu data anak pada akun pribadinya.
- 3) Peserta didik dan anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan melakukan pendaftaran dengan mengisi biodata diri lengkap di antaranya nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan data lainnya.
- 4) Setelah selesai mendaftar, peserta didik dan anak usia 7 – 17 tahun di luar satuan pendidikan akan mendapatkan Tiket CKG.
- 5) Setelah mendapat Tiket CKG peserta didik dan anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan perlu mengisi kuesioner H-7 dengan membuka halaman Tiket CKG.
- 6) Tanggal pelaksanaan CKG Sekolah akan diinformasikan oleh sekolah/madrasah/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat kepada peserta didik atau orang tua/wali. Tanggal pelaksanaan CKG Sekolah bagi anak usia 7-17 tahun

di luar satuan pendidikan melalui akun SSM setelah mendaftar.

b. Pendaftaran melalui *WhatsApp Chatbot*

- 1) Peserta didik dan anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan atau orang tua/wali dapat melakukan pendaftaran CKG Sekolah melalui *WhatsApp* Layanan Kesehatan Primer Kemenkes RI di nomor 0812-7887-8812.
- 2) Pendaftaran dilakukan dengan mengetik “kado” lalu klik atau memilih “Pendaftaran” dan mengisi formulir biodata lengkap.
- 3) Setelah selesai pendaftaran, *screenshot* (tangkap layar) nomor Tiket CKG untuk melakukan pengisian skrining mandiri melalui tautan yang diberikan melalui *WhatsApp*.

c. Bagi peserta didik dan anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan yang tidak memiliki Telepon Seluler, petugas Puskesmas dapat mendaftarkan melalui *Website* SATUSEHAT IndonesiaKu dan menggunakan *link/QR code* yang disediakan untuk membantu pengisian kuesioner mandiri sebelum pemberian pelayanan CKG Sekolah.

d. Mendaftarkan/mengaktifkan kepesertaan JKN

Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat pemeriksaan kesehatan dan penanganannya, bagi peserta didik dan anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan yang belum menjadi peserta JKN atau status kepesertaan tidak aktif, agar didaftarkan orang tua/wali menjadi peserta JKN aktif sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Mengakses Hasil Pemeriksaan kesehatan

Setelah mendapatkan pelayanan CKG, peserta didik atau orang tua/wali dapat mengakses hasil pemeriksaan kesehatan melalui SATUSEHAT Mobile (SMM) dan *whatsapp*.

C. Pelaksanaan CKG Sekolah

1. Tujuh hari sebelum pelaksanaan

- a. Tenaga Puskesmas berkoordinasi dengan sekolah tentang pelaksanaan CKG, menyampaikan tata cara pendaftaran, dan mengingatkan pengisian kuesioner skrining mandiri yang perlu diisi oleh peserta didik atau orang tua/wali. Tautan kuesioner skrining mandiri dapat diakses melalui akun SSM atau WhatsApp masing-masing pada halaman yang digunakan untuk pendaftaran sebelumnya.
- b. Sekolah/Guru memberikan informasi kepada orang tua/wali tentang skrining kesehatan yang akan dilakukan, tata cara pendaftaran CKG Sekolah dan pengisian kuesioner skrining.
- c. Puskesmas berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk menentukan jadwal dan mengidentifikasi kebutuhan dan penyediaan alat kesehatan, ruangan dan lapangan tempat pemeriksaan kesehatan di sekolah.

2. Dua hari sebelum pelaksanaan

- a. Tenaga Puskesmas mengecek jumlah pendaftaran peserta didik, keterisian kuesioner mandiri dan menyiapkan alat kesehatan serta BMHP.
- b. Tenaga Puskesmas memberikan umpan balik kepada sekolah mengenai jumlah pendaftar dan jika terdapat peserta didik yang belum mengisi kuesioner skrining mandiri secara lengkap.

3. Hari pelaksanaan

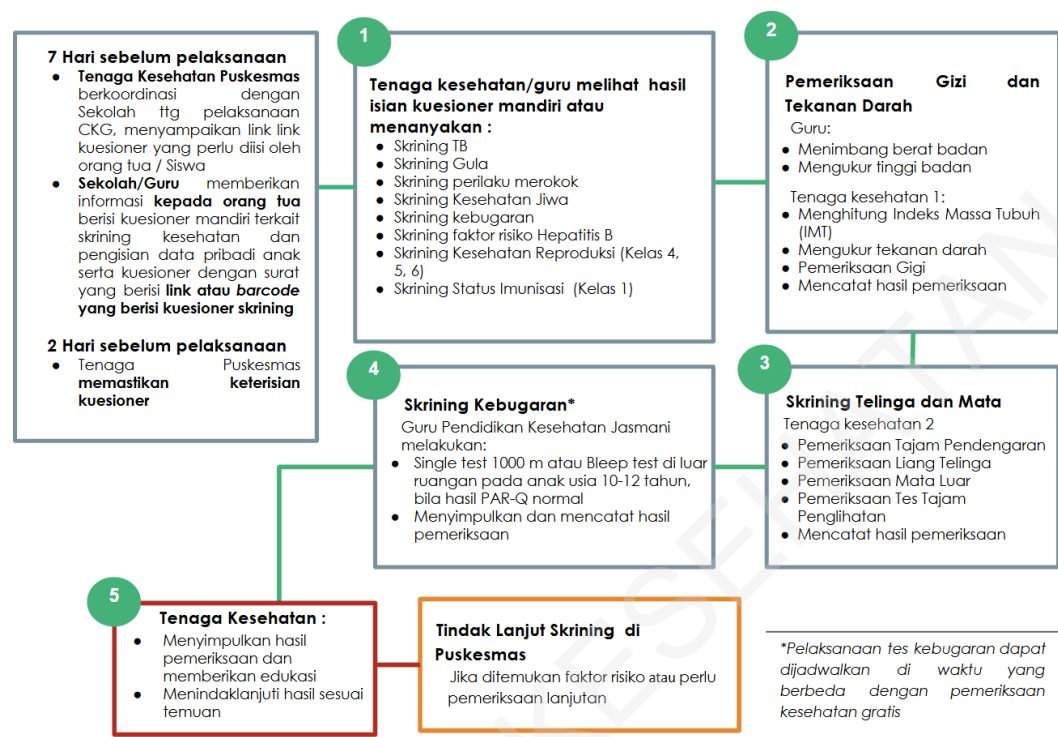
- a. Peserta didik mengikuti pelaksanaan CKG Sekolah di satuan pendidikan, tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan membantu memastikan peserta didik telah mengisi data diri dan kuesioner mandiri.
- b. Jika peserta didik belum terdata, maka petugas menginput data peserta didik melalui website SATUSEHAT IndonesiaKu.
- c. Pembagian tugas mengikuti saat persiapan pemeriksaan kesehatan Anak Sekolah.
- d. Tenaga Puskesmas datang pada hari pemeriksaan kesehatan Anak Sekolah:
 - 1) Petugas mengidentifikasi kondisi disabilitas untuk menyesuaikan cara komunikasi, interaksi dan pemeriksaan kesehatan serta kebutuhan alat/media bantu.

- 2) Petugas melakukan identifikasi dan mengkaji hasil skrining mandiri yang telah didapatkan.
 - 3) Petugas memberikan pelayanan CKG.
 - 4) Petugas mencatat hasil pemeriksaan di Website SATUSEHAT IndonesiaKu (SSI) secara *real time* agar peserta didik mendapat hasil pemeriksaan segera.
- e. Petugas memberikan informasi hasil pemeriksaan CKG Sekolah
- 1) Jika hasil sudah tersedia, Petugas Puskesmas akan langsung menyampaikan hasil, saran, dan tindak lanjut pemeriksaan CKG Sekolah.
 - 2) Jika hasil pemeriksaan CKG Sekolah belum tersedia, peserta didik akan mendapatkan informasi pada saat hasil pemeriksaan CKG Sekolah sudah tersedia.
 - 3) Keseluruhan hasil pemeriksaan CKG Sekolah akan dikirimkan melalui WA dan/atau dapat diakses pada akun SSM.
- f. Tenaga Puskesmas melakukan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan
- g. Peserta didik yang tidak dapat mengakses CKG Sekolah pada hari pelaksanaan dapat mengakses pelayanan di FKTP terdekat.

Untuk mengetahui lebih jelas terkait alur dan jenis pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada kelompok sasaran:

1. Peserta didik kelas 1-6 SD/MI/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan anak usia 7-12 tahun di luar satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4 dan Tabel 2.
2. Peserta didik Kelas 7-9 SMP/MTs/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan anak usia 13-15 tahun di luar satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 3.
3. Peserta didik kelas 10-12 SMA/SMK/MA/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan anak usia 16-17 tahun di luar satuan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 4.

Gambar 4. Alur dan Jenis Pemeriksaan Peserta Didik Kelas 1-6 SD/MI/Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat dan Anak Usia 7-12 Tahun di Luar Satuan Pendidikan



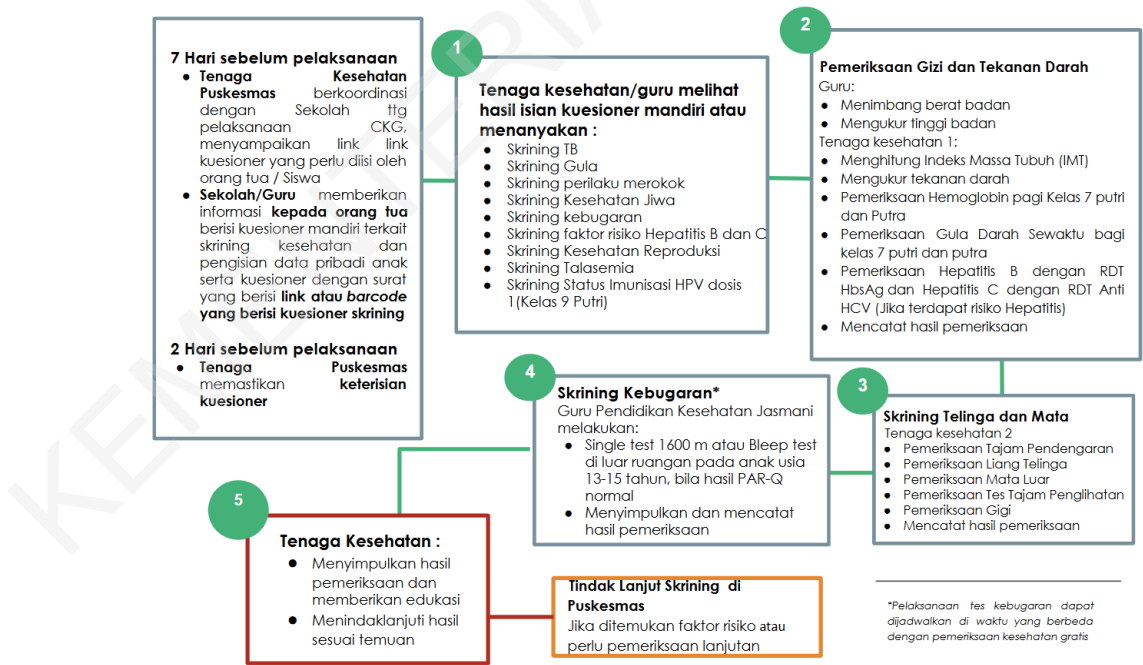
Tabel 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bagi Peserta Didik Kelas 1-6 SD/MI/Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat dan Anak Usia 7-12 Tahun di Luar Satuan Pendidikan

Layanan Skrining		Hasil	Tindak Lanjut
Gizi (berat badan, tinggi badan dan indeks massa tubuh)		Normal	• Pertahankan Pola Hidup Sehat meliputi pola dan perilaku makan serta aktivitas fisik • Pengukuran antropometri secara berkala (setiap 6 bulan)
		Gizi Buruk	Rujuk ke Puskesmas
		Gizi Kurang	• Edukasi dan konseling dengan materi gizi seimbang, perhitungan kebutuhan gizi untuk mencapai status gizi normal, penentuan jenis diet, penyusunan menu • Jika ada komplikasi dirujuk ke Puskesmas
		Gizi Lebih	• Edukasi dan konseling dengan materi gizi seimbang, perhitungan kebutuhan gizi untuk mencapai status gizi normal, penentuan jenis diet, penyusunan menu • Olahraga rutin minimal 3-5 kali per minggu • Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya (jika ada komplikasi), lanjutkan dengan pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)
		Obesitas	
Riwayat Imunisasi Rutin		Lengkap	Beri edukasi untuk terapkan pola hidup bersih dan sehat serta ikuti imunisasi saat Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
		Tidak lengkap	Beri edukasi untuk melengkapi imunisasi dengan melakukan imunisasi kejar di Puskesmas atau fasyankes lainnya.
Merokok		Tidak Merokok	• Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/ tahun
		Tidak Terpapar asap rokok orang lain	• Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/ tahun
		Terpapar asap rokok orang lain	• Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. • Lakukan pemeriksaan lanjutan di Puskesmas jika terdapat keluhan
		Merokok	• Berikan Nasihat Singkat Singkat (Brief Advice) berhenti merokok • Lakukan konseling Upaya Berhenti Merokok di Puskesmas
Kebugaran	Tingkat Aktivitas Fisik	Aktivitas Fisik Cukup	Edukasi gaya hidup sehat untuk peningkatan aktivitas fisik
		Aktivitas Fisik Kurang	Edukasi gaya hidup sehat, Rujuk Puskesmas jika ada penyakit penyerta lainnya.
		Memenuhi	Lanjutkan pemeriksaan kebugaran setelah pemanasan dengan

Layanan Skrining		Hasil	Tindak Lanjut
	PAR-Q <i>child</i>		single test lari jarak menengah 1000 meter atau bleep test untuk anak usia 10-12 tahun
		Tidak memenuhi	Tunda skrining, konsultasi dengan dokter Dirujuk ke Puskesmas
	Single test atau Bleep test	Baik sekali/Baik	• Aktivitas fisik 60 menit setiap hari sesuai dengan olahraga dan kegiatan yang disukai • Ikuti klub olahraga atau atlet olahraga
		Cukup	• Motivasi untuk aktivitas fisik setiap hari 30-60 menit setiap hari (ditingkatkan bertahap) • Analisis catatan kebiasaan aktivitas fisik dan riwayat penyakit • Latihan fisik sesuai rekomendasi
Telinga	Tes Tajam Pendengaran	Kurang/Kurang sekali	• Dirujuk ke Puskesmas, cek hasil skrining peserta didik, apakah ada masalah kesehatan • Motivasi untuk Aktivitas fisik setiap hari 30-60 menit setiap hari (ditingkatkan bertahap) • Analisis catatan kebiasaan aktivitas fisik dan riwayat penyakit yang diderita
		Dapat mengulang kata lebih dari 80% (minimal 4 dari 5)	Hasil Normal Edukasi kesehatan telinga dan pendengaran (Batasi penggunaan earphone /lingkungan bising dengan volume besar dan durasi lama
	Serumen impaksi	Tidak dapat mengulang kata lebih dari 80% (kurang dari 4 dari 5)	Ditemukan gangguan pendengaran Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Tidak Ada Serumen Impaksi	Edukasi untuk menjaga kebersihan telinga (Jaga kebersihan telinga dan tidak mengorek telinga menggunakan benda apapun)
	Infeksi	Ada serumen impaksi	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Tidak Ada Infeksi Telinga	Edukasi untuk menjaga kebersihan telinga (Jaga kebersihan telinga dan tidak mengorek telinga menggunakan benda apapun)
Mata	Pemeriksaan Mata Luar	Ada Infeksi Telinga	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Mata sehat	• Edukasi cara pencegahan penularan penyakit mata dengan menjaga kebersihan diri • Batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak menggunakan gadget
	Tes tajam penglihatan	Mata tidak sehat	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Normal: Visus 6/6 - 6/9	• Edukasi cara pencegahan penularan penyakit mata dengan menjaga kebersihan diri • Batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak menggunakan gadget • Lakukan pemeriksaan berkala setahun sekali
Gigi		Ada Indikasi Gangguan Penglihatan (visus < 6/9)	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Tidak ada karies	• Edukasi Kesehatan Gigi: Jaga kebersihan gigi, menggosok gigi 2 kali sehari, sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam • Gunakan pasta gigi berfluoride • Pemberian fluorida topikal pada gigi sebanyak 2 kali pertahun • Kurangi makanan/ minuman manis dan asam, diet gizi seimbang, dan tidak merokok
Jiwa		Karies	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Normal	Edukasi kesehatan jiwa oleh guru. Bila guru belum dibekali untuk memberi edukasi ini, dapat meminta bantuan tenaga kesehatan
Tekanan Darah		Berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Dirujuk ke Puskesmas dan Pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh petugas kesehatan
		Normal Sistolik dan diastolik < persentil 90	Edukasi gaya hidup sehat
		Pre hipertensi Sistolik dan diastolik ≥ persentil 90 tetapi <persentil 95, atau 120/80 mmHg tetapi < persentil 95	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Hipertensi tingkat 1 Sistolik dan diastolik diantara persentil 95	

Layanan Skrining		Hasil	Tindak Lanjut
		dan persentil 95 +12 mmHg atau 130/80 mmHg - 138/89 mmHg	
		Hipertensi Tingkat 2 Sistolik atau Diastolik ≥ persentil 95 +12 mmHg atau ≥ 140/90 mmHg	
Gula Darah	Keluhan, tanda, dan gejala DM	Tidak ada	- Edukasi pola hidup sehat dan pencegahan diabetes - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
		Ada	Rujuk Ke Puskesmas / Fasilitas kesehatan lainnya
Tuberkulosis		Tidak terdapat tanda, gejala dan kontak erat TB	Edukasi pola hidup sehat dan pencegahan TB
		Terdapat tanda atau gejala (terduga)	- Dirujuk ke Puskesmas untuk penegakan diagnosis dengan pemeriksaan sputum dengan TCM atau sistem skoring (jika sputum tidak bisa diperoleh) - Pemeriksaan dilanjutkan di ruang infeksius
		Terdapat kontak erat TB positif	- Dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan eligibilitas bagi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) - Pengaturan Investigasi Kontak - Pemeriksaan dilanjutkan di ruang infeksius
Hati	Faktor Risiko hepatitis B	Tidak Berisiko	Edukasi pencegahan dan penularan Hepatitis B
		Berisiko	Dirujuk untuk pemeriksaan hati sesuai faktor risiko ke Puskesmas
Kesehatan Reproduksi		Normal	Edukasi Kesehatan Reproduksi
		Berisiko	Dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di Puskesmas

Gambar 5. Alur dan Jenis Pemeriksaan peserta didik Kelas 7-9 SMP/MTs/ Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat dan Anak Usia 13-15 Tahun di Luar Satuan Pendidikan



Tabel 3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bagi Peserta Didik Kelas 7-9 SMP/MTs/Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat dan Anak Usia 13-15 Tahun di Luar Satuan Pendidikan

Layanan Skrining		Hasil	Tindak lanjut
Gizi (berat badan, tinggi badan dan indeks massa tubuh)		Normal	• Pertahankan Pola Hidup Sehat meliputi pola dan perilaku makan serta aktivitas fisik • Pengukuran antropometri secara berkala (setiap 6 bulan)
		Gizi Buruk	Rujuk Ke Puskesmas
		Gizi Kurang	• Edukasi dan konseling dengan materi gizi seimbang, perhitungan kebutuhan gizi untuk mencapai status gizi normal, penentuan jenis diet, penyusunan menu • Jika ada komplikasi dirujuk ke Puskesmas
		Gizi Lebih	• Edukasi dan konseling dengan materi gizi seimbang, perhitungan kebutuhan gizi untuk mencapai status gizi normal, penentuan jenis diet, penyusunan menu • Olahraga rutin minimal 3-5 kali per minggu • Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya (jika ada komplikasi), lanjutkan dengan pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)
		Obesitas	
Riwayat Imunisasi HPV		Sudah imunisasi HPV	Beri edukasi untuk terapkan pola hidup bersih dan sehat
		Belum imunisasi HPV	Beri edukasi untuk mendapatkan imunisasi HPV saat kegiatan BIAS atau di Puskesmas atau fasyankes lainnya
Merokok		Tidak Merokok	• Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/ tahun
		Tidak Terpapar asap rokok orang lain	• Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/ tahun
		Terpapar asap rokok orang lain	• Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. • Lakukan pemeriksaan lanjutan di Puskesmas jika terdapat keluhan
		Merokok	• Berikan Nasihat Singkat Singkat (Brief Advice) berhenti merokok • Lakukan konseling Upaya Berhenti Merokok di Puskesmas
Kebugaran	Tingkat Aktivitas Fisik	Aktivitas Fisik Cukup	Edukasi gaya hidup sehat untuk peningkatan aktivitas fisik
		Aktivitas Fisik Kurang	Edukasi gaya hidup sehat, Rujuk Puskesmas jika ada penyakit penyerta lainnya.
	PAR-Q <i>child</i>	Memenuhi	Lanjutkan pemeriksaan kebugaran setelah pemanasan dengan single test lari jarak menengah 1600 Meter atau bleep test untuk anak usia 13-15 tahun
		Tidak memenuhi	Tunda skrining, konsultasi dengan dokter Dirujuk ke Puskesmas
	Single test atau Bleeptest	Baik sekali/Baik	Aktivitas fisik 60 menit setiap hari sesuai dengan olahraga dan kegiatan yang disukai Ikuti klub olahraga atau atlet olahraga
		Cukup	• Motivasi untuk aktivitas fisik setiap hari 30-60 menit setiap hari (ditingkatkan bertahap). • Analisis catatan kebiasaan aktivitas fisik dan riwayat penyakit. • Latihan fisik sesuai rekomendasi

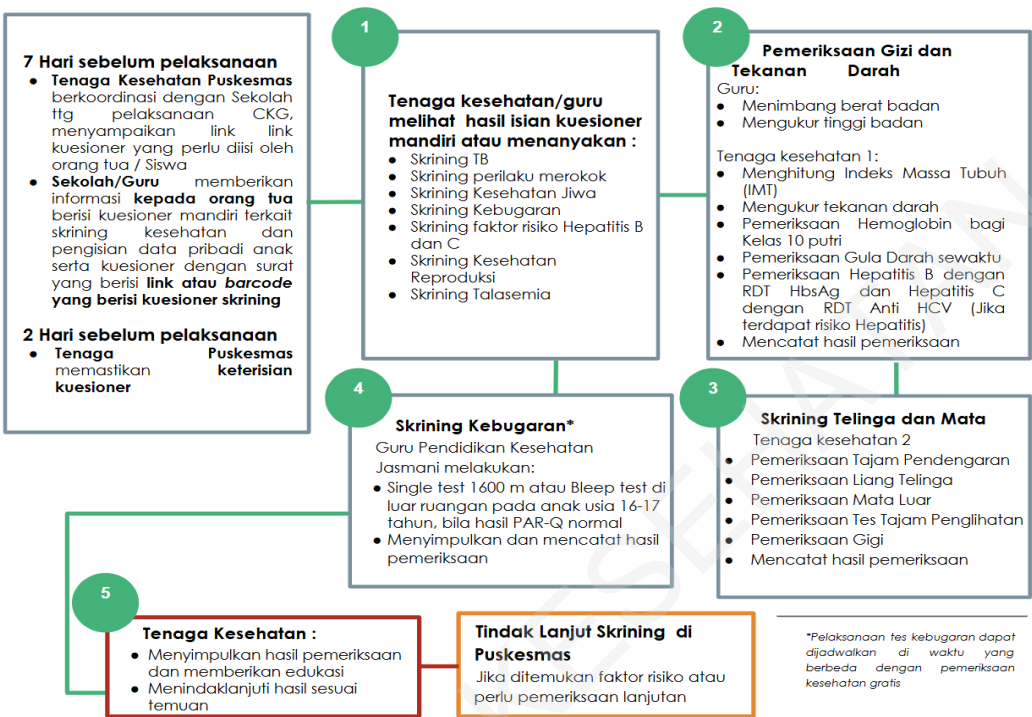
Layanan Skrining		Hasil	Tindak lanjut
		Kurang/Kurang sekali	• Tingkatkan secara bertahap aktivitas fisik 30 - 60 menit setiap harinya. • Catat kebiasaan aktivitas fisik setiap hari untuk dievaluasi guru atau tenaga kesehatan. • Atasi masalah kesehatan lain seperti obesitas atau overweight • Lakukan pemeriksaan kebugaran jasmani 3 sd 6 bulan berikut.
Telinga	Tes Tajam Pendengaran	Dapat mengulang kata lebih dari 80% (minimal 4 dari 5)	Hasil Normal Edukasi kesehatan telinga dan pendengaran (Batasi penggunaan earphone /lingkungan bising dengan volume besar dan durasi lama
		Tidak dapat mengulang kata lebih dari 80% (kurang dari 4 dari 5)	Ditemukan gangguan pendengaran Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
	Serumen impaksi	Tidak Ada Serumen Impaksi	Edukasi untuk menjaga kebersihan telinga (Jaga kebersihan telinga dan tidak mengorek telinga menggunakan benda apapun)
		Ada serumen impaksi	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
	Infeksi	Tidak Ada Infeksi Telinga	Edukasi untuk menjaga kebersihan telinga (Jaga kebersihan telinga dan tidak mengorek telinga menggunakan benda apapun)
		Ada Infeksi Telinga	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
Mata	Pemeriksaan Mata Luar	Mata sehat	• Edukasi cara pencegahan penularan penyakit mata dengan menjaga kebersihan diri • Batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak menggunakan gadget
		Mata tidak sehat	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
	Tes tajam penglihatan	Normal: Visus 6/6 - 6/9	• Edukasi cara pencegahan penularan penyakit mata dengan menjaga kebersihan diri • Batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak menggunakan gadget • Lakukan pemeriksaan berkala setahun sekali
		Ada Indikasi Gangguan Penglihatan (visus < 6/9)	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
Gigi		Tidak ada karies	• Edukasi Kesehatan Gigi; Jaga kebersihan gigi • Menggosok gigi 2 kali sehari, sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. • Gunakan pasta gigi berfluoride • Kurangi makanan/minuman manis
		Karies	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
Jiwa		Normal	Edukasi kesehatan jiwa oleh guru. Bila guru belum dibekali untuk memberi edukasi ini, dapat meminta bantuan tenaga kesehatan
		Berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Edukasi kesehatan jiwa oleh guru. Bila guru belum dibekali untuk memberi edukasi ini, dapat meminta bantuan tenaga kesehatan Dirujuk ke Puskesmas dan Pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh petugas kesehatan

Layanan Skrining		Hasil	Tindak lanjut		
Tekanan Darah		Normal (<120/80 mmHg)	- Edukasi gaya hidup sehat - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun		
		Prehipertensi (120/<80 mmHg s.d 129/<80 mmHg)	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya		
		Hipertensi tingkat 1 (130/80 mmHg s.d 138/89 mmHg)			
		Hipertensi tingkat 2 (≥ 140/90 mmHg)			
Gula Darah	Kelas 7 / 13 tahun: Diperiksa GDS	Hipoglikemia	Konsumsi makanan atau minuman manis seperti permen atau larutan air gula, segera konsultasi ke Rumah Sakit		
		Normal	- Edukasi pola hidup sehat dan pencegahan diabetes - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun		
		Pre-Diabetes	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya		
		Hiperglikemia			
	Kelas 8-9 / 14 – 15 tahun: Ditanya Keluhan, tanda, dan gejala DM	Tidak ada	- Edukasi pola hidup sehat dan pencegahan diabetes - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun		
		Ada	- Lanjutkan dengan pemeriksaan glukosa darah sewaktu (GDS), - Jika GDS >140 mg/dL dirujuk ke Puskesmas/fasilitas Kesehatan lainnya		
Anemia Pada kelas 7 Putri dan Putra		Tidak anemia (Hb ≥ 12 g/dL)	- Edukasi bagi remaja putri untuk tetap konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 1 tablet per minggu - Terapkan perilaku hidup sehat - Konsumsi makanan dengan gizi seimbang - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun		
		Anemia ringan (Hb 11.0-11.9 g/dL)	- Diberikan TTD untuk dikonsumsi 1 tablet/hari selama 4 minggu - Konsumsi Gizi Seimbang	Rujuk ke Puskesmas untuk melanjutkan pemeriksaan talasemia (Hb, MCV, MCH, jumlah eritrosit)	
		Anemia sedang (Hb 8.0-10.9) g/dL)	- Diberikan TTD untuk dikonsumsi 2 tablet/hari selama 4 minggu - Konsumsi Gizi Seimbang		
		Anemia berat (Hb <8 g/dL)	- Dirujuk ke ke Puskesmas/FKTL - Rujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan talasemia (Hb, MCV, MCH, jumlah eritrosit) - Klinis buruk (sesuai tanda dan gejala anemia berat) dirujuk ke RS. Memastikan rematri telah dirujuk dan mendapat tata laksana di RS		
Talasemia	Ditanyakan riwayat keluarga	Tidak ada	Edukasi pemahaman tentang talasemia		
		Ada	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya		
Tuberkulosis		Tidak terdapat tanda, gejala dan kontak erat TB	Edukasi pola hidup sehat dan pencegahan TB		
		Terdapat tanda atau gejala (terduga)	- Dirujuk ke Puskesmas untuk penegakan diagnosis dengan pemeriksaan sputum dengan TCM atau sistem skoring (jika sputum tidak bisa diperoleh) - Pemeriksaan dilanjutkan di ruang infeksius		
		Terdapat kontak erat TB positif	- Dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan eligibilitas bagi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) - Pengaturan Investigasi Kontak - Pemeriksaan dilanjutkan di ruang infeksius		
Hati	Faktor Risiko	Tidak Berisiko	Edukasi pencegahan dan penularan Hepatitis B		

Layanan Skrining		Hasil	Tindak lanjut		
	Hepatitis B	Berisiko	Pemeriksaan RDT HBsAg	HBsAg non reaktif	- Edukasi Pencegahan dan Penularan - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
				HBsAg reaktif	- Jika lab Puskesmas memadai pemeriksaan HBV DNA atau HBeAg, ALT/SGPT dan SGOT, trombosit - Dirujuk ke RS bila lab Puskesmas tidak memadai
	Faktor Risiko Hepatitis C	Tidak Berisiko	Edukasi pencegahan dan penularan Hepatitis C		
		Berisiko	Pemeriksaan RDT anti HCV	Anti HCV non reaktif	- Edukasi Pencegahan dan Penularan - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
				Anti HCV reaktif	- Jika lab Puskesmas memadai periksakan HCV RNA - Dirujuk ke RS bila lab Puskesmas tidak memadai
Kesehatan Reproduksi		Normal	Edukasi kesehatan reproduksi		
		Berisiko	Dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di Puskesmas		

Pemeriksaan di Puskesmas				
Layanan Skrining		Hasil	Tindak Lanjut	
1. Memiliki riwayat keluarga 2. Kelas 7 yang anemia	Hb, MCV, MCH dan Jumlah Eritrosit	Indeks Mentzer >13 dan indeks shine and LAL >1530	- Berikan kartu/sertifikat telah deteksi dini talasemia - Menginfokan klien bahwa pemeriksaan ini hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup - Anemia Defisiensi Besi, Lanjutkan konsumsi TTD sesuai anjuran	
		Indeks Mentzer <13 dan/atau indeks Shine dan LAL <1530	Tersangka talasemia Minor, Dirujuk ke FKRTL	

Gambar 6. Alur dan Jenis Pemeriksaan bagi Peserta Didik Kelas 10-12 SMA/SMK/MA/ Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat dan Anak Usia 16-17 Tahun di Luar Satuan Pendidikan



Tabel 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bagi Peserta Didik Kelas 10-12 SMA/SMK/MA/ Pesantren atau Satuan Pendidikan Lain yang Sederajat dan Anak Usia 16-17 Tahun di Luar Satuan Pendidikan

Layanan Skrining	Hasil	Tindak lanjut
Gizi (berat badan, tinggi badan dan indeks massa tubuh)	Normal	- Pertahankan Pola Hidup Sehat meliputi pola dan perilaku makan serta aktivitas fisik - Pengukuran antropometri secara berkala (setiap 6 bulan)
	Gizi Buruk	Rujuk ke Puskesmas
	Gizi Kurang	- Edukasi dan konseling dengan materi gizi seimbang, perhitungan kebutuhan gizi untuk mencapai status gizi normal, penentuan jenis diet, penyusunan menu - Jika ada komplikasi dirujuk ke Puskesmas
	Gizi Lebih	Edukasi dan konseling dengan materi gizi seimbang, perhitungan kebutuhan gizi untuk mencapai status gizi normal, penentuan jenis diet, penyusunan menu
	Obesitas	- Olahraga rutin minimal 3-5 kali per minggu - Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya (jika ada komplikasi), lanjutkan dengan pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)
Merokok	Tidak Merokok	- Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/ tahun
	Tidak Terpapar asap rokok orang lain	- Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. - Lakukan pemeriksaan berkala 1x/ tahun
	Terpapar asap rokok orang lain	- Edukasi gaya hidup sehat dan hindari paparan asap rokok. - Lakukan pemeriksaan lanjutan di Puskesmas jika terdapat keluhan
	Merokok	- Berikan Nasihat Singkat Singkat (Brief Advice) berhenti merokok - Lakukan konseling Upaya Berhenti Merokok di Puskesmas

Layanan Skrining		Hasil	Tindak lanjut
Kebugaran	Tingkat Aktivitas Fisik	Aktivitas Fisik Cukup	• Edukasi gaya hidup sehat untuk peningkatan aktivitas fisik
		Aktivitas Fisik Kurang	• Edukasi gaya hidup sehat, Rujuk Puskesmas jika ada penyakit penyerta lainnya.
	PAR-Q <i>child</i>	Memenuhi	• Lanjutkan pemeriksaan kebugaran setelah pemanasan dengan single test lari jarak menengah 1600 meter atau bleep test
		Tidak memenuhi	• Tunda skrining, konsultasi dengan dokter • Dirujuk ke Puskesmas
	Single test atau Bleep test	Baik sekali/Baik	• Aktivitas fisik 60 menit setiap hari sesuai dengan olahraga dan kegiatan yang disukai • Ikuti klub olahraga atau atlet olahraga
		Cukup	• Motivasi untuk aktivitas fisik setiap hari 30-60 menit setiap hari (ditingkatkan bertahap). • Analisis catatan kebiasaan aktivitas fisik dan riwayat penyakit. • Latihan fisik sesuai rekomendasi
		Kurang/Kurang sekali	• Dirujuk ke Puskesmas, cek hasil skrining peserta didik, apakah ada masalah kesehatan • Motivasi untuk Aktivitas fisik setiap hari 30-60 menit setiap hari (ditingkatkan bertahap) • Analisis catatan kebiasaan aktivitas fisik dan riwayat penyakit yang diderita
Telinga	Tes Tajam Pendengaran	Dapat mengulang kata lebih dari 80% (minimal 4 dari 5)	Hasil Normal Edukasi kesehatan telinga dan pendengaran (Batasi penggunaan earphone /lingkungan bising dengan volume besar dan durasi lama
		Tidak dapat mengulang kata lebih dari 80% (kurang dari 4 dari 5)	Ditemukan gangguan pendengaran Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
	Serumen impaksi	Tidak Ada Serumen Impaksi	Edukasi untuk menjaga kebersihan telinga (Jaga kebersihan telinga dan tidak mengorek telinga menggunakan benda apapun)
		Ada serumen impaksi	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
	Infeksi	Tidak Ada Infeksi Telinga	Edukasi untuk menjaga kebersihan telinga (Jaga kebersihan telinga dan tidak mengorek telinga menggunakan benda apapun)
		Ada Infeksi Telinga	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
Mata	Mata Luar	Mata sehat	• Edukasi pencegahan penularan penyakit mata dengan kebersihan diri • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun • Batasi pemakaian gadget
		Mata tidak sehat	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
	Tes tajam penglihatan	Normal: Visus 6/6 - 6/9	• Edukasi kesehatan mata • Batasi aktivitas melihat dekat • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
		Ada Indikasi Gangguan Penglihatan (visus)< 6/9	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
Gigi		Tidak ada karies	• Edukasi Kesehatan Gigi • Jaga kebersihan gigi • Menggosok gigi 2 kali sehari, sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. • Gunakan pasta gigi berfluoride • Kurangi makanan/ minuman manis
		Karies	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
Jiwa		Normal	Edukasi kesehatan jiwa oleh guru. Bila guru belum dibekali untuk memberi edukasi ini, dapat meminta bantuan tenaga kesehatan
		Berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Dirujuk ke Puskesmas dan Pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh petugas kesehatan
Tekanan Darah		Normal (<120/80 mmHg)	• Edukasi gaya hidup sehat • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
		Prehipertensi (120/<80 mmHg s.d 129/<80 mmHg)	• Konseling dan edukasi gaya hidup sehat • Datang ke Puskesmas 1x/bulan untuk pemantauan tekanan darah
		Hipertensi tingkat 1 (130/80 mmHg s.d 138/89 mmHg)	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Hipertensi tingkat 2 (≥ 140/90 mmHg)	
Gula Darah		Hipoglikemia	Konsumsi makanan atau minuman manis seperti permen atau larutan air gula, segera konsultasi ke Rumah Sakit
		Normal	• Edukasi pola hidup sehat dan pencegahan diabetes • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
		Pre-Diabetes	Dirujuk ke Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya
		Hiperglikemia	

Layanan Skrining		Hasil		Tindak lanjut	
Anemia Pada kelas 10 Putri		Tidak anemia (Hb $\geq$ 12 g/dL)		• Edukasi bagi remaja putri untuk tetap konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 1 tablet per minggu • Terapkan perilaku hidup sehat • Konsumsi makanan dengan gizi seimbang • Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun	
		Anemia ringan (Hb 11.0-11.9 g/dL)		• Diberikan TTD untuk dikonsumsi 1 tablet/hari selama 4 minggu • Konsumsi Gizi Seimbang	Rujuk ke Puskesmas untuk melanjutkan pemeriksaan talasemia (Hb, MCV, MCH, jumlah eritrosit)
		Anemia sedang (Hb 8.0-10.9) g/dL)		• Diberikan TTD untuk dikonsumsi 2 tablet/hari selama 4 minggu • Konsumsi Gizi Seimbang	
		Anemia berat (Hb $<$ 8 g/dL)		• Dirujuk ke Puskesmas/FKTL • Rujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan talasemia (Hb, MCV, MCH, jumlah eritrosit) • Klinis buruk (sesuai tanda dan gejala anemia berat) dirujuk ke RS. Memastikan rematri telah dirujuk dan mendapat tata laksana di RS	
Tuberkulosis		Tidak terdapat tanda, gejala dan kontak erat TB		Edukasi pola hidup sehat dan pencegahan TB	
		Terdapat tanda atau gejala (terduga)		• Dirujuk ke Puskesmas untuk penegakan diagnosis dengan pemeriksaan sputum dengan TCM atau sistem skoring (jika sputum tidak bisa diperoleh) • Pemeriksaan dilanjutkan di ruang infeksius	
		Terdapat kontak erat TB positif		• Dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan eligibilitas bagi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) • Pengaturan Investigasi Kontak • Pemeriksaan dilanjutkan di ruang infeksius	
Hati	Faktor Risiko Hepatits B	Tidak berisiko	Edukasi pencegahan dan penularan Hepatitis B		
		Berisiko	Pemeriks aan RDT HBsAg	HBsAg non reaktif	• Edukasi Pencegahan dan Penularan Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
				HBsAg reaktif	• Jika lab Puskesmas memadai periksakan HBV DNA atau HBeAg, ALT/SGPT dan SGOT trombosit • Dirujuk ke RS bila lab Puskesmas tidak memadai
	Faktor Risiko Hepatitis C	Tidak berisiko	Edukasi pencegahan dan penularan Hepatitis C		
		Berisiko	Pemeriks aan RDT anti HCV	Anti HCV non reaktif	• Edukasi Pencegahan dan Penularan Lakukan pemeriksaan berkala 1x/tahun
				Anti HCV reaktif	• Jika lab Puskesmas memadai periksakan HCV RNA. • Dirujuk ke RS bila lab Puskesmas tidak memadai
Kesehatan Reproduksi		Normal		Edukasi kesehatan reproduksi	
		Berisiko		Dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di Puskesmas	

Pemeriksaan di Puskesmas			
Layanan Skrining		Hasil	Tindak Lanjut
1. Talasemia 2. Memiliki riwayat keluarga Kelas 10 remaja putri yang anemia	Hb, MCV, MCH dan Jumlah Eritrosit	Indeks Mentzer $>$ 13 dan indeks shine and LAL $>$ 1530	• Berikan kartu/sertifikat telah deteksi dini talasemia • Menginformasikan klien bahwa pemeriksaan ini hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup • Anemia Defisiensi Besi, Lanjutkan konsumsi TTD sesuai anjuran
		Indeks Mentzer $<$ 13 dan/atau indeks Shine dan LAL $<$ 1530	Tersangka talasemia Minor, Dirujuk ke FKRTL

Khusus pada daerah endemis perlu dilakukan pemeriksaan tambahan oleh tenaga Puskesmas (dokter, perawat, bidan atau tenaga teknologi laboratorium medik) disesuaikan dengan pedoman teknis program pengendalian masing-masing penyakit, antara lain meliputi:

1. Malaria, dengan metode:
 - a. bagi peserta didik kelas 1-6 SD/MI/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan anak usia 7-12 tahun di luar satuan Pendidikan pada Kabupaten/kota endemis tinggi dilakukan dengan pengisian kuesioner mandiri sesuai dengan faktor resiko dilanjutkan dengan pemeriksaan RDT Malaria atau mikroskopis di Puskesmas.
 - b. bagi peserta didik Kelas 7-9 SMP/MTs/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan peserta didik kelas 10-12 SMA/SMK/MA/pesantren atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan anak usia 13-17 tahun di luar satuan pendidikan pada kabupaten/kota endemis tinggi dilakukan pemeriksaan RDT Malaria di satuan pendidikan atau Puskesmas atau pemeriksaan mikroskopis di Puskesmas.
2. Kusta dilakukan dengan metode pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di satuan pendidikan pada kabupaten/kota dengan beban tinggi.
3. Skabies dilakukan dengan metode pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di satuan pendidikan pada kabupaten/kota dengan kasus tinggi.

Tindak lanjut pemeriksaan malaria, kusta, dan skabies dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Malaria, Kusta, dan Skabies

Layanan Skrining		Hasil	Tindak Lanjut
Kusta	Bercak Kulit	Tidak ada bercak kulit	Tidak kusta, Edukasi PHBS, bila kontak kusta: siapkan POPM /kemoprofilaksis Kusta dengan Rifampisin dosis tunggal
		Ada bercak kulit tidak mati rasa	Bukan kusta, Edukasi PHBS, bila kontak kusta: siapkan POPM /kemoprofilaksis Kusta dengan Rifampisin dosis tunggal
		Ada bercak kulit mati rasa	Rujuk ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan tanada-tanda utama Kusta apabila positif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan BTA Kusta

Layanan Skrining		Hasil	Tindak Lanjut
Scabies		Tidak ada koreng yang gatal	Tidak scabies, edukasi PHBS, Edukasi mengenal dan pencegahan penyakit scabies
		Ada koreng kulit bergerombol gatal	Rujuk Ke Puskesmas untuk tatalaksana lebih lanjut
Malaria	Terdapat gejala demam, sakit kepala, dan menggigil	Tidak	Edukasi pencegahan dan penularan malaria
		Ya	Rujuk Puskesmas untuk pemeriksaan dan tatalaksana Malaria lebih lanjut
	Pernah sakit Malaria dan obat tidak habis diminum	Tidak	Edukasi pencegahan dan penularan malaria
		Ya	Rujuk Puskesmas untuk pemeriksaan dan tatalaksana Malaria lebih lanjut
	Ada orang sakit Malaria di wilayah tempat tinggal (di rumah atau tetangga sekitar rumah)	Tidak	Edukasi pencegahan dan penularan malaria
		Ya	Rujuk Puskesmas untuk pemeriksaan dan tatalaksana Malaria lebih lanjut
	Rapid Test	Non Reaktif	Edukasi pencegahan dan penularan malaria
		Reaktif	Rujuk Puskesmas untuk pemeriksaan dan tatalaksana Malaria lebih lanjut

Tindak lanjut hasil CKG Sekolah dapat dilakukan secara individu maupun kelompok/massal.

1. Tindak lanjut secara individu dilakukan sesuai hasil pemeriksaan dari tiap individu peserta didik. Tindak lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, atau Tabel 5 di atas.
2. Tindak lanjut secara kelompok dilakukan setelah analisis hasil CKG Sekolah di setiap satuan pendidikan. Analisis dilakukan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan sekolah untuk melihat masalah kesehatan pada peserta didik di wilayah kerjanya.
3. Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil analisis, dimana petugas Puskesmas didampingi tenaga pendidik/tenaga kependidikan memberikan edukasi terkait topik kesehatan tertentu berdasarkan masalah kesehatan terbanyak dari hasil CKG pada sekolah tersebut dengan melibatkan orang tua/wali peserta didik.

Contoh:

- a. Jika ditemukan banyak anak dengan karies gigi di suatu sekolah, dilakukan penyuluhan cara merawat gigi dan cara melakukan sikat gigi yang benar.
- b. Jika ditemukan banyak anak dengan obesitas dan gizi lebih, dilakukan intervensi edukasi gizi seimbang dan peningkatan aktivitas fisik secara berkelompok.

- c. Jika ditemukan banyak anak dengan kebugaran kurang dan kurang sekali, dilakukan peningkatan aktivitas fisik rutin setiap minggu.
- d. Edukasi Kesehatan menjadi bagian dari Usaha Kesehatan Sekolah yang diintegrasikan secara intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB IV

PENDANAAN

Pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan CKG Sekolah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam program CKG Sekolah dapat dilakukan dengan dukungan dari APBN berupa DAK Non Fisik atau sumber pendanaan lain dari Pemerintah Daerah. Penyediaan BMHP dapat dipenuhi melalui permohonan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, dan dinas kesehatan provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Pengajuan BMHP ke Kementerian Kesehatan memperhitungkan alokasi BMHP yang dianggarkan melalui kapitasi, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan transportasi petugas Puskesmas yang mengunjungi satuan pendidikan untuk melaksanakan CKG Sekolah menggunakan anggaran DAK Non Fisik yang dikelola oleh Puskesmas melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan anggaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran CKG Sekolah sebagai peserta aktif JKN yang memerlukan tindak lanjut pemeriksaan dan pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pendanaannya dilakukan melalui mekanisme JKN, sedangkan yang bukan peserta aktif JKN pendanaannya ditanggung secara mandiri.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pemeriksaan kesehatan dalam program CKG Sekolah harus dicatat dan dilaporkan oleh petugas Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan melalui Pencatatan platform SATUSEHAT IndonesiaKu (SSI) dengan alamat sehatindonesiaku.kemkes.go.id. Pastikan petugas sudah memiliki akun website SATUSEHAT IndonesiaKu (SSI). Akun SSI dapat didaftarkan oleh admin SSI di Puskesmas/Dinkes Kabupaten/Kota atau Provinsi. Dashboard monitoring pendaftaran dan dashboard analisis hasil layanan bagi Puskesmas/Dinkes Kab/Kota/Prov/Kemenkes dapat diakses menggunakan Website SSI.

Untuk implementasi jangka panjang, Puskesmas dan FKTP lainnya yang telah menyelenggarakan Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) untuk memudahkan pelaporan CKG sekolah harus mengadopsi modul pelayanan CKG dan/atau SATUSEHAT RME agar dapat mengintegrasikan datanya ke dalam SATUSEHAT. Semua pencatatan dan pelaporan wajib dilakukan secara *real-time*.

Platform SATUSEHAT merupakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) yang memiliki fungsi integrator dan standarisasi Data Kesehatan dan Informasi Kesehatan. Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan masyarakat, termasuk juga korporasi wajib mengintegrasikan Data Kesehatan dan Informasi Kesehatan ke Platform SATUSEHAT sesuai ketentuan pasal 345 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, atas Data dan Informasi Pelaksanaan CKG, termasuk CKG Sekolah yang diproses oleh FKTP dan/atau PSE diintegrasikan ke Platform SATUSEHAT.

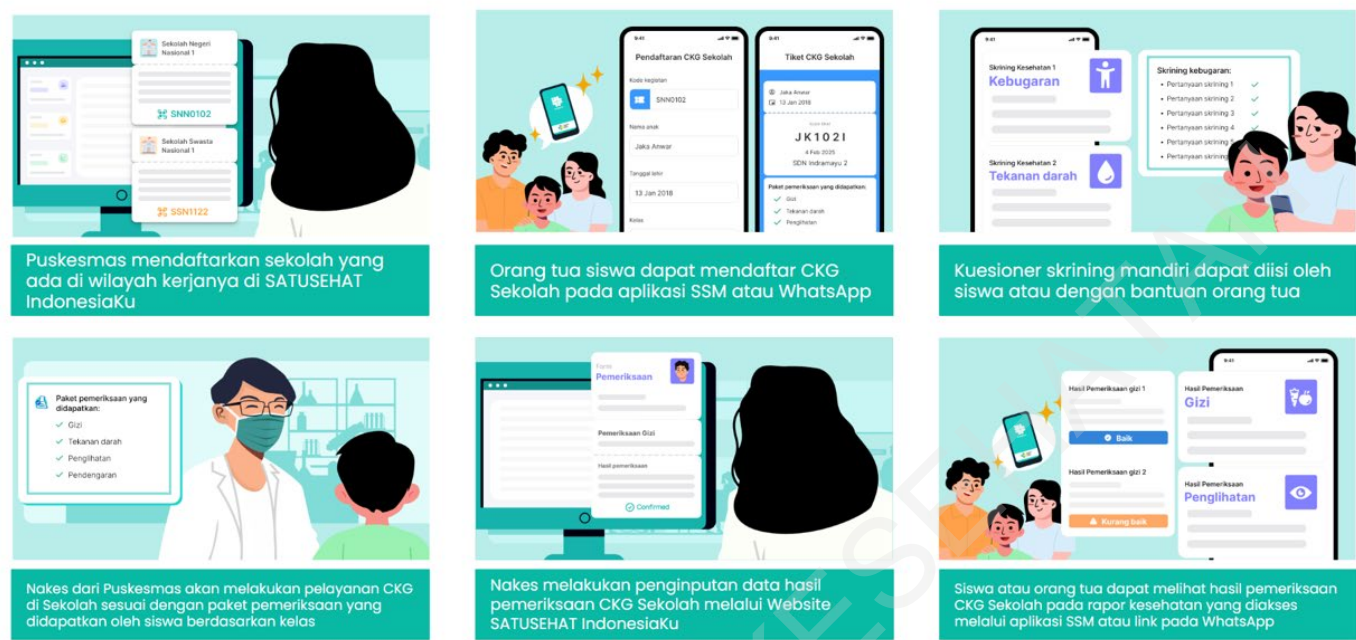
Mekanisme integrasi dilaksanakan paling sedikit sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. secara elektronik melalui pemrograman antarmuka (*application programming interface*);
2. memenuhi standar data dan interoperabilitas;
3. *real time*; dan
4. aman.

Pihak yang melakukan integrasi Data dan Informasi Pelaksanaan CKG ke Platform SATUSEHAT menandatangani Pakta Integritas dan menyepakati petunjuk teknis integrasi.

Skema pencatatan dan pelaporan yang dilakukan melalui platform SATUSEHAT dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini:

Gambar 7 Skema Pencatatan dan Pelaporan



BAB VI

STRATEGI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

Strategi komunikasi yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program CKG Sekolah. Pendekatan dilakukan secara terintegrasi dan berbasis pada identifikasi permasalahan komunikasi yang muncul dengan sasaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali.

Komunikasi dilakukan dengan berbagai pendekatan atau metode seperti komunikasi massa, komunikasi antar pribadi dan komunikasi perubahan perilaku. Komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan dengan penetapan tujuan yang tepat, pemetaan khalayak yang sesuai, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi yang adaptif, pembuatan pesan yang mudah dipahami masing-masing sasaran hingga evaluasi, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mampu mengubah perilaku peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pelaksanaan CKG pada anak sekolah dilakukan atas sepengetahuan dan pemberian izin dari orang tua/wali, sehingga penyampaian informasi yang tepat sebelum pelaksanaan CKG kepada orang tua/wali mutlak diperlukan.

A. Tujuan Strategi Komunikasi CKG Sekolah

1. Semua sasaran CKG sekolah mengikuti CKG sekolah
2. Semua sasaran CKG sekolah melakukan tindak lanjut hasil CKG sekolah

B. Sasaran Edukasi

Sasaran edukasi untuk CKG Sekolah adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan di lingkup satuan pendidikan, dan anak usia 7-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan serta orang tua/wali.

C. Pesan Kunci

Pesan kunci untuk mendukung CKG Sekolah disesuaikan dengan kelompok sasaran dan juga sosial budaya setempat sehingga menjadi relevan dan mudah dipahami. *Tagline* yang digunakan “**Cek Kesehatan Gratis Sekolah!**”

1. Pesan Utama

Merupakan pesan yang dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan CKG Sekolah dan melakukan tindak lanjut hasil skrining.

Pesan Utama pada kampanye ini adalah **“Yuk Ikuti Cek Kesehatan Gratis Sekolah!”**

2. Pesan Pendukung

Pesan pendukung adalah informasi spesifik yang dapat memperkuat pesan utama dari suatu strategi komunikasi. Pesan kunci pendukung dirancang untuk memberikan penjelasan lebih mendalam, menjawab potensi pertanyaan, atau memperkuat kepercayaan audiens terhadap pesan utama.

Tabel 6. Pesan Kunci dalam CKG Sekolah

Tujuan	Perilaku yang diharapkan	Hambatan	Pesan
Menggerakkan peserta didik mengikuti CKG Sekolah	Mengikuti CKG Sekolah	• Orang tua/wali tidak mengizinkan • Cemas dan takut mengetahui hasil pemeriksaan	Pesan menitikberatkan pada informasi CKG Sekolah dan manfaat CKG Contoh pesan : • Sekolah Mulai, Cek Kesehatan Gratis Jangan Terlewat • Mau Sehat Berprestasi, Yuk Lakukan Cek Kesehatan Setiap Tahun di Sekolah! • Cek kesehatan bukan hal yang perlu ditakuti, tetapi langkah positif untuk menggapai cita-cita di masa depan. • Cek kesehatan gratis sekolah adalah kado terbaik untuk kamu, Gratis! • Ayah Bunda mau anaknya sehat berprestasi? Ikuti cek kesehatan anak ya! • Bapak/Ibu Guru yuk ajak siswa/i nya untuk rutin cek kesehatan!
Menggerakkan peserta didik melakukan tindak lanjut hasil CKG Sekolah	Hasil normal tidak ada faktor risiko : • Mempertahankan perilaku hidup sehat • Mengikuti CKG di Sekolah satu kali setahun setiap tahun ajaran baru	• Kesulitan dalam menjadikan perilaku hidup sehat sebagai kebiasaan yang harus terus - menerus dilakukan • Tidak mengetahui bahwa cek kesehatan harus dilakukan secara berkala setiap tahun ajaran baru satu tahun sekali	Pesan menitikberatkan pada informasi tentang pentingnya melakukan CKG berkala, pentingnya dan cara/tips menerapkan perilaku hidup sehat. Pesan dapat disesuaikan dengan hambatan spesifik lokal yang ditemukan Contoh pesan : • Lakukan Cek kesehatan gratis di sekolah satu kali setahun untuk memastikan tubuh tetap sehat dan produktif! • Sekolah mulai, yuk cek kesehatan gratis di sekolah! • Terapkan perilaku hidup sehat melalui makan

Tujuan	Perilaku yang diharapkan	Hambatan	Pesan
			<i>bergizi seimbang, beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.</i> • <i>Jaga kesehatan gigi dengan rutin periksa gigi 6 bulan sekali</i>
	Hasil normal dengan faktor risiko : • Memperbaiki pola hidup agar lebih sehat • Mengendalikan faktor risiko • Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala	• Tidak mengetahui penerapan perilaku hidup sehat • Tidak mengetahui dampak dari faktor risiko karena merasa sehat • Tidak mengetahui pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengendalikan faktor risiko	Pesan menitikberatkan pada informasi tentang pentingnya penerapan perilaku hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mengendalikan faktor risiko. Pesan dapat disesuaikan dengan hambatan spesifik lokal yang ditemukan Contoh pesan : • <i>Terapkan perilaku hidup sehat melalui makan bergizi seimbang, beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.</i> • <i>Berat Badan berlebih dapat meningkatkan risiko Diabetes, yuk atur pola makan dan beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari!</i> • <i>Supaya makin keren, yuk mulailah dengan kurangi porsi makan, pilih makanan rendah kalori dan beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari.</i> • <i>Jaga penampilan dengan gigi sehat, gosok gigi rutin setelah sarapan dan sebelum tidur</i>
	Hasil di ambang batas/ <i>borderline</i> : • Memperbaiki pola hidup agar lebih sehat • Melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas pelayanan kesehatan	• Tidak mengetahui penerapan perilaku hidup sehat • Tidak ada gejala yang dirasakan • Tidak merasa sakit secara fisik	Pesan menitikberatkan pada informasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan apa yang harus dilakukan jika hasil pemeriksaan di ambang batas/ <i>borderline</i>. Pesan dapat disesuaikan dengan hambatan spesifik lokal yang ditemukan Contoh pesan : • <i>Mau jadi generasi keren, kurangi makanan cepat saji ya!</i> • <i>Jangan mager, kalau kamu mau punya power!</i>

Tujuan	Perilaku yang diharapkan	Hambatan	Pesan
			• <i>Periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali.</i>
	Hasil abnormal (terdeteksi penyakit): • Memperbaiki pola hidup sehat • Mengakses pelayanan kesehatan rujukan (jika diperlukan) • Minum obat atau vitamin/ mineral secara rutin sesuai anjuran dokter • Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin	• Menunda atau tidak mengakses layanan rujukan • Minum obat atau vitamin/ mineral tidak rutin karena tidak suka rasanya atau takut efek samping	Pesan menitikberatkan pada informasi tentang mengapa dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup walau telah terdeteksi penyakit dan agar minum obat teratur. Pesan dapat disesuaikan dengan hambatan spesifik lokal yang ditemukan Contoh pesan: • <i>Jaga kesehatan gigi dengan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali.</i> • <i>Sikat gigi secara rutin sebelum sarapan dan setelah makan siang, mampu menjaga kesehatan gigi.</i> • <i>Kadar Hb tidak normal/anemia?Yuk perbaiki pola makan dan rutin minum Tablet Tambah Darah yaa!</i> • <i>Berat Badan kamu berlebih? Yuk mulai sekarang perbaiki pola makan bergizi seimbang dan rutin aktivitas fisik 30 menit sehari ya</i> • <i>Hasil CKG menunjukkan Hipertensi? Eits, jangan khawatir, tetap ikuti saran dokter dan rutin periksa ya!</i> • <i>Bisa hidup sehat dengan Diabetes? Yuk minum obat sesuai anjuran dokter dan pantau gula darah secara rutin!</i> • <i>Obat bukan musuh kok, tetapi senjata melawan penyakit : rutin minum obat Hipertensi sesuai anjuran dokter ya</i> • <i>Kendalikan tekanan darah dengan jaga pola makan, rutin beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari. kelola stres dan minum obat sesuai anjuran dokter</i> • <i>Jangan bosan minum obat, Yuk tuntaskan rutin minum obat, Tuberkulosis bisa sembuh!</i> • <i>Kendalikan emosi berlebihan dengan konsul ke Guru</i>

Tujuan	Perilaku yang diharapkan	Hambatan	Pesan
			<i>BK/keluarga terdekat, kelola stres dan minum obat sesuai anjuran dokter.</i> • <i>Kontrol rutin ke dokter adalah perlindungan terbaik, jangan ditunda ya!</i>

Catatan:

- Dalam penyampaiannya, pesan-pesan tersebut dapat disesuaikan, diparafrasekan kembali, atau ditambahkan agar sesuai dengan tantangan, karakteristik *audiens* (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua) dan situasi sosial budaya setempat.
- Sebelum merumuskan pesan kesehatan perlu dilakukan survei sebagai langkah penting untuk memperkaya pemahaman tentang masyarakat, serta menjamin bahwa pesan yang disampaikan relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima. Dengan memahami kebutuhan, hambatan, dan preferensi audiens melalui survei, pesan kesehatan dapat disusun secara lebih efektif dan berdampak.

D. Kegiatan Komunikasi Cek Kesehatan Gratis Sekolah

Dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi dan edukasi terkait CKG Sekolah, perlu dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Kegiatan edukasi dan penyebaran informasi oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui kampanye, seminar/webinar, penyebaran informasi pada media penyiaran, media online atau media massa, penggerakan masyarakat, komunitas dan mitra seperti pada *Car Free Day* terutama yang banyak melibatkan orang tua dan anak usia sekolah, dan lain sebagainya.
2. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Kegiatan edukasi dan penyebaran informasi oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui sosialisasi di kegiatan-kegiatan sektor pendidikan seperti rapat koordinasi dan bimbingan teknis, seminar/webinar, penyebaran informasi pada media publikasi dan komunikasi, media online atau media massa, penggerakan masyarakat, terutama yang banyak melibatkan orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, anak usia

sekolah, satuan pendidikan dan mitra seperti pada kegiatan Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan, dan lain sebagainya.

3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kegiatan edukasi dan penyebarluasan informasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui sosialisasi di kegiatan-kegiatan sektor keagamaan seperti rapat koordinasi dan bimbingan teknis di madrasah/pesantren, kampanye di kegiatan-kegiatan Kementerian Agama, seminar/webinar, penyebarluasan informasi pada media penyiaran, media online atau media massa, penggerakan masyarakat terutama yang banyak melibatkan orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, anak usia sekolah di madrasah/pesantren, komunitas dan mitra seperti pada Hari Santri Nasional, acara keagamaan, dan lain sebagainya.

4. Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kegiatan edukasi dan penyebarluasan informasi oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui kampanye di kegiatan-kegiatan sektor sosial, seperti Pameran Pelayanan Sosial, Sekolah Rakyat, seminar/webinar untuk pendamping PKH, penyebarluasan informasi pada media penyiaran, media online atau media massa, penggerakan masyarakat, komunitas dan mitraseperti pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, dan lain sebagainya.

5. Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan kegiatan edukasi dan penyebarluasan informasi CKG Sekolah melalui jam literasi sekolah, kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), rapat dan pertemuan orang tua/wali dan komite sekolah pada awal tahun ajaran baru, grup WhatsApp pendidik dan orang tua/wali, mading sekolah, media sosial sekolah, dan kegiatan kesiswaan yang melibatkan peserta didik dll.

Penyebarluasan informasi tentang CKG Sekolah dapat juga diperluas cakupannya melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan secara rutin oleh Perguruan Tinggi seperti Kuliah Kerja Nyata yang banyak dilakukan di masyarakat dan pesantren, pelaksanaan edukasi kesehatan di masyarakat oleh Poltekkes, dan lain sebagainya.

6. Kegiatan di Masyarakat/komunitas

Penyebarluasan informasi tentang CKG Sekolah juga dapat dilakukan melalui saluran komunikasi berbasis komunitas seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), forum anak, forum kepala sekolah, forum pesantren, arisan RT/RW, kegiatan keagamaan, Dasa Wisma, Karang Taruna, Kelompok Tani, komunitas olahraga dan lain sebagainya. Hal ini disesuaikan dengan tujuan komunikasi, karakteristik audiens, sumber daya yang ada dan lain sebagainya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Keberhasilan pelaksanaan CKG Sekolah dilihat dari kesesuaian perencanaan, tujuan, cakupan pelayanan serta dukungan dari pemerintah daerah, sektor pendidikan, agama serta mitra. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CKG Sekolah dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan pendidikan, Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat Pusat, melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait.

Mengacu pada indikator RPJMN 2025 - 2029 Pemeriksaan Kesehatan Gratis, maka monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1. Bagi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi

Indikator Keberhasilan:

Persentase kabupaten/kota dengan cakupan $\geq 80\%$ penduduk mendapatkan CKG.

2. Bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota

Indikator keberhasilan:

Persentase jumlah penerima CKG pada anak sekolah usia 7-17 tahun terhadap jumlah penduduk.

3. Bagi Puskesmas yang menyelenggarakan CKG Sekolah

Indikator Keberhasilan:

Persentase penduduk penerima CKG dengan kelompok anak sekolah usia 7-17 tahun. Persentase Peserta didik di kelas 1-12 sederajat yang mendapatkan CKG Sekolah.

Pemantauan hasil penyelenggaraan CKG Sekolah dilakukan melalui pengamatan *Dashboard* SATUSEHAT secara *real time*, untuk melihat *gap* antara capaian dengan target per bulan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara target dengan capaian pada bulan tersebut maka harus dilakukan pendampingan/bimbingan teknis/supervisi fasilitatif secara berjenjang.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui berbagai mekanisme kegiatan berikut:

1. lokakarya mini bulanan Puskesmas
2. pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor
3. pertemuan evaluasi bersama sekolah; dan/atau
4. pendampingan, bimbingan teknis, dan supervisi fasilitatif ke Puskesmas.

BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan CKG Sekolah menekankan pentingnya peran aktif peserta didik dalam menjaga kesehatan serta pembentukan pola hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya pencegahan sejak dini. Melalui program ini, peserta didik dengan dukungan pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua diharapkan termotivasi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia demi kebaikan diri sendiri dan keluarga.

Dengan adanya CKG Sekolah, masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah untuk pelayanan kesehatan berkualitas. Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa deteksi dini, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih berfokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, petugas kesehatan, dan masyarakat memegang peran kunci dalam memastikan keberlanjutan program ini. Kerjasama yang solid akan memperkuat upaya pencegahan penyakit, mengurangi beban pelayanan kesehatan rujukan, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung visi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, tangguh, dan produktif.

Petunjuk teknis pelaksanaan diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan CKG Sekolah. Dengan pelaksanaan yang terarah, masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi dini penyakit dan faktor risiko, serta mendapatkan penanganan tepat waktu. Program ini menjadi langkah penting menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif, mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003